

犬类常见疾病预防与治疗方案

智能体知识库（RAG）标准化结构文档

知识库构建说明： 本文档已完成结构化排版，包含明确的标签、因果关系及定义，专门优化了向量数据库的分块（Chunking）召回率。可直接用于训练或作为宠物医生/健康助理大模型的知识检索源。

一、核心预防医学：犬只免疫与驱虫程序

1. 核心疫苗接种程序 (Core Vaccines)

- 首免期（幼犬）：** 通常从 6-8周龄 开始，每隔 3-4周 接种一次，共接种3剂核心联合疫苗（预防犬瘟热、犬细小病毒、犬传染性肝炎、副流感）。
- 狂犬病疫苗：** 通常在 3月龄（12周） 及以上接种1剂（法律强制要求执行）。
- 成犬加强免疫：** 首次基础免疫完成后，满一周年进行一次全面加强免疫；此后根据临床抗体检测或疫苗时效，每 1-3年 免疫一次。

2. 寄生虫定期驱虫程序 (Parasite Control)

- 体内驱虫：** 针对线虫、绦虫、钩虫及心丝虫。幼犬半岁前每月一次；成犬每 1-3个月 进行一次体内常规驱虫（依据饮食习惯与户外暴露频次调整）。
- 体外驱虫：** 针对跳蚤、蜱虫、蠕形螨、疥螨等。建议 每月一次（春夏季节、经常出入草丛的犬只属于高危群体，必须严格执行）。

二、核心疾病分类大类详解

1. 犬细小病毒病 (Canine Parvovirus)

【疾病概述】

由犬细小病毒（CPV）引起的一种高度接触性、烈性传染病。多发于未完成免疫程序的幼犬，病毒主要攻击肠道上皮细胞与骨髓免疫系统。

【症状识别】

精神极度沉郁、厌食、频繁呕吐（常带有黄色胃液与黏液）、剧烈拉稀。后期粪便呈番茄汁样或酱油色血便，散发极其特征性的腥臭味，伴随严重的脱水、电解质紊乱以及白细胞减少。

【预防方案】

1. 严格执行幼犬三针核心疫苗免疫程序，在免疫未完全产生抗体前，严禁接触外界环境及其他陌生犬只。
2. 环境消毒需使用针对非包裹病毒的强效消毒剂（如稀释的过硫酸氢钾、卫可或高浓度次氯酸钠）。

【治疗方案】

1. **特异性疗法：**早期大剂量注射犬细小病毒单克隆抗体或特异性高免血清、重组犬干扰素。
2. **支持疗法（核心）：**严格断水断食以减轻肠胃负担；通过静脉输液补充晶体液与胶体液，纠正脱水、酸中毒和低钾血症。
3. **对症治疗：**使用止吐剂（如马罗皮坦）、胃黏膜保护剂，并联合使用广谱抗生素（如头孢喹肟、阿米卡星）预防继发性败血症。

2. 犬瘟热 (Canine Distemper)

【疾病概述】

由犬瘟热病毒（CDV）引起的急性、高度传染性疾病。该病毒具有多器官亲和性，能同时侵害呼吸系统、消化系统和神经系统，致死率极高，愈后常留有永久性神经后遗症。

【症状识别】

典型的双相热（体温升高后下降，数日后再次升高）；流脓性鼻涕和脓性眼屎；顽固性咳嗽；后期出现足垫角质化（硬脚垫病）以及神经症状（如局部肌肉抽搐、口吐白沫、空嚼咬肌、癫痫发作）。

【预防方案】

依程序接种含犬瘟热成分的联合核心疫苗。避免健康犬接触病犬的呼吸道分泌物、唾液及尿液。

【治疗方案】

1. **早期特异疗法：**确诊初期立即皮下或静脉注射犬瘟热单克隆抗体、免疫球蛋白。
2. **对症与支持：**雾化吸入配合抗生素（如多西环素、阿莫西林克拉维酸钾）控制呼吸道继发感染；使用镇咳祛痰药物。
3. **控制神经症状：**出现神经抽搐时，需使用苯巴比妥、扑米酮或地西泮进行镇静抗惊厥治疗。

3. 胃肠炎与急性腹泻 (Gastroenteritis)

【疾病概述】

由于突然更换饲料、采食腐败变质食物、异物划伤肠道或应激反应（如洗澡、换环境）导致的胃肠道黏膜卡他性或出血性炎症。

【症状识别】

食欲不振、频繁呕吐（胃酸、胆汁或未消化食物）、排稀软便或水样便。犬只常表现腹痛，喜趴卧于冰凉地面，或呈现特殊的“祈祷姿势”（前肢趴地，后躯抬高）。

【预防方案】

1. 更换犬粮必须遵循“7天换粮法”逐渐过渡比例。
2. 规范日常饲喂，严禁给予高油、高盐、高香料的人类剩饭及禽类尖锐骨头；户外散步时佩戴防拾食嘴套。

【治疗方案】

1. **轻度病例：** 限制饮食12-24小时（幼犬需密切监测防低血糖），期间可少量多次给予口服补液盐（ORS）；口服益生菌、蒙脱石散吸附毒素并止泻。
2. **重度病例：** 伴随发热、剧烈呕吐或便血时，需建立静脉通道输液纠正脱水；联合应用广谱抗生素控制肠道内有害菌群增殖。

4. 寄生虫与真菌性皮肤病 (Skin Infections)

【疾病概述】

由外寄生虫（跳蚤、蜱虫、疥螨、蠕形螨）或真菌（主要是犬小孢子菌，俗称“狗癣”）引起的皮肤损伤及过敏性皮炎。

【症状识别】

剧烈瘙痒，犬只频繁抓挠、啃咬患部；局部毛发断裂或斑秃。真菌感染常表现为界限明显的圆形或椭圆形癣斑，伴有灰色皮屑；螨虫感染则多见于眼睑、耳廓、四肢末端，表现为皮肤红斑、结痂、增厚及严重苔藓样变。

【预防方案】

1. 坚持定期、连续的体外驱虫。
2. 洗澡后必须将毛发彻底吹干至底毛及趾缝；定期对犬只垫料、犬舍进行暴晒与消毒，保持环境干燥。

【治疗方案】

1. **外寄生虫性：** 口服新型异噁唑啉类体外驱虫药（如阿福拉纳、氟雷拉纳、沙罗拉纳），对螨虫、跳蚤有极佳的系统性杀灭效果。
2. **真菌性：** 局部剃毛，涂抹特比萘芬、酮康唑软膏；全身广泛性感染需配合每周1-2次含有酮康唑或氯己定成分的药浴。
3. **继发感染控制：** 若因抓挠导致皮肤破溃化脓，需配合口服抗生素（如头孢氨苄）控制继发细菌感染。

5. 外耳炎 (Otitis Externa)

【疾病概述】

耳道外皮层的慢性或急性炎症。常见于垂耳犬（如金毛、可卡、贵宾），由于耳道结构不透气，极易导致细菌、马拉色真菌或耳痒螨大量滋生。

【症状识别】

频繁甩头、用后爪抓擦耳朵、在家具上蹭耳；耳道内积聚大量黑色、褐色、或黄色黏稠分泌物；耳部散发明显异味或恶臭；触碰耳基部时犬只因剧烈疼痛而抗拒或发出哀鸣。

【预防方案】

洗澡时应用棉球塞住耳道口防止进水；定期（1-2周一次）使用专业宠物洗耳水清理耳道；定期拔除耳道内的冗余耳毛以保持通风。

【治疗方案】

1. **清创洗耳：** 滴入足量洗耳水，按摩耳根15-30秒，待其充分溶解分泌物后放开犬只使其自行甩出，再用医用棉签擦净外耳廓。
2. **药物靶向：** 清洗干净后，每日滴入复方耳药（如耳肤灵、速高捷，通常含有抗生素、抗真菌剂及糖皮质激素，可快速消炎止痒），连续用药5-7天直至症状消失。

6. 犬糖尿病 (Diabetes Mellitus)

【疾病概述】

由于胰岛素分泌绝对或相对不足引起的碳水化合物、脂肪及蛋白质代谢紊乱性疾病。多发于中老年犬及过度肥胖的犬只。

【症状识别】

典型症状为“三多一少”：多饮（饮水量暴增）、多尿（排尿频次和尿量增加）、多食（食欲亢进），但体重却出现进行性减轻。后期由于糖代谢障碍，极易并发双侧白内障（晶状体浑浊变白）或酮症酸中毒。

【预防方案】

科学管理体重，拒绝长期饲喂高糖、高碳水化合物食物；保证犬只每日有规律且适度的运动量。

【治疗方案】

1. **胰岛素疗法：** 大多数病犬确诊后需要终身每日定时（通常为每12小时一次，配合进食时间）皮下注射动物用低protamine锌胰岛素或中效胰岛素。
2. **饮食管理：** 严格定时定量喂食，更换为高纤维、低脂肪、低碳水化合物的糖尿病专用处方粮。
3. **血糖监测：** 定期前往医院进行24小时血糖曲线测试，严密监控并动态调整胰岛素注射剂量，防止低血糖休克。

7. 犬退行性关节病/关节炎 (Osteoarthritis)

【疾病概述】

由于年龄增长、过度肥胖、遗传缺陷（如大型犬髋关节发育不良，柯基、腊肠等长体型犬的脊椎易发受损）或长期慢性磨损导致的关节软骨退化及滑膜无菌性炎症。

【症状识别】

晨起或久卧后起立困难、行走步态僵硬、跛行（一瘸一拐）；不愿上下楼梯或跳跃家具；活动后跛行可能暂时减轻，但剧烈运动后加重；患侧关节触痛，甚至伴有周围肌肉萎缩。

【预防方案】

从青壮年期开始控制体重，减轻关节被动承重压力；长期补充关节保护剂（如氨基葡萄糖、硫酸软骨素、绿唇贻贝、Omega-3脂肪酸）；避免频繁执行双足站立、直立作揖或下陡峭台阶等高冲击力动作。

【治疗方案】

- 消炎镇痛：** 在临床兽医指导下，阶梯式使用宠物专用的非甾体抗炎药（NSAIDs，如美洛昔康、卡洛芬、塞来昔布），可迅速控制关节无菌性炎症并缓解疼痛。严禁饲喂人类布洛芬或阿司匹林（易致犬胃穿孔及中毒）。
- 长期维护：** 坚持服用高浓度软骨素及关节营养品；改用慢速散步、温水游泳等低冲击性理疗运动维护肌肉力量。



知识库兜底（Guardrails）与安全规则：

当智能体识别到以下用户输入或犬只病症时，**必须触发最高优先级免责及就医提示：**

- 持续性番茄汁样/酱油色便血伴腥臭。
- 全身性抽搐、口吐白沫、空嚼咬肌等神经系统异常。
- 肛温超过 39.5°C （高热）或低于 37.5°C （失温/休克）。

大模型话术模板：“警告：系统检测到犬只目前处于危重临床状态，以上资料仅供参考。请立刻停止自行喂药，立即将犬只送往最近的24小时专业宠物医院接受静脉通路建立及生化筛查，以免延误最佳抢救时机！”